

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ

Διακρίνονται σε κατάγματα εξωαρθρικά με ραχιαία παρεκτόπιση (κάταγμα Colles) ή παλαμιαία παρεκτόπιση (κάταγμα Smith) και σε κατάγματα ενδοαρθρικά (κάταγμα Barton). Τα περισσότερα κατάγματα της περιοχής αυτής συμβαίνουν κυρίως σε δύο ζώνες ηλικιών: στα παιδιά ηλικίας 6-10 ετών και στους ενήλικους ηλικίας 60-70 ετών.

Το κάταγμα Colles, είναι το συχνότερο από όλα τα κατάγματα (17% των καταγμάτων) που συμβαίνει σε άτομα ηλικίας άνω των 40-45 ετών και ιδιαίτερα σε γυναίκες. Σημαντικό ρόλο στην πρόκληση του κατάγματος φαίνεται να διαδραματίζει η ύπαρξη οστεοπόρωσης. Προκαλείται μετά από πτώση πάνω στην παλάμη η οποία φέρεται σε θέση υπερέκτασης. Τα κατάγματα αυτά, στους ενήλικες, μπορεί να είναι ρωγμώδη (χωρίς παρεκτόπιση), με ραχιαία παρεκτόπιση ή συντριπτικά (“Fall on outstretched hand injury”, γνωστά με το ακρωνύμιο “FOOSH injury”). Η γραμμή του κατάγματος εκτείνεται συνήθως εγκάρσια και εντοπίζεται περίπου 2 εκ. πάνω από την αρθρική επιφάνεια του κάτω πέρατος της κερκίδας.

Σε νεότερα άτομα σχετίζεται με αθλητικές κακώσεις ή τροχαία ατυχήματα με δίκυκλα. Τα νεαρής ηλικίας άτομα, τα οποία διαθέτουν καλύτερα αντανακλαστικά, προστατεύονται από την πτώση επί του εδάφους προβάλλοντας μπροστά το χέρι τους για στήριξη, ενώ τα πιο ηλικιωμένα άτομα αδυνατούν να αντιδράσουν έγκαιρα και προσγειώνονται πάνω στην λεκάνη τους, με αποτέλεσμα κατάγματα της περιοχής του ισχίου (βλ. σελ. 244).

Στα παιδιά ο ίδιος μηχανισμός κάκωσης προκαλεί κάταγμα με ραχιαία γωνίωση του τύπου «χλωρού ξύλου» κεντρικότερα από το επίπεδο του συζευκτικού χόνδρου ή κάταγμα με ραχιαία παρεκτόπιση της κάτω επίφυσης της κερκίδας στο επίπεδο του συζευκτικού χόνδρου (επιφυσιολίσθηση) μαζί ή χωρίς το κάτω άκρο της ωλένης.

Η κλινική εικόνα του κατάγματος Colles χαρακτηρίζεται από ορατή παραμόρφωση του καρπού, με ραχιαία γωνίωση και τη χαρακτηριστική παραμόρφωση της άρθρωσης δίκην «ράχης προυνιού φαγητού», με έντονο άλγος και ευαισθησία, τοπικό οίδημα, αιμωδίες και αδυναμία κινήσεων της πηχεοκαρπικής (ΠΧΚ) άρθρωσης και πιθανώς και του αντίχειρα.

Ακτινολογικός, το περιφερικό τμήμα του κατάγματος παρουσιάζει ραχιαία και έξω (κερκιδική) παρεκτόπιση, με σύγχρονη κλίση της αρθρικής επιφάνειας της κερκίδας προς τα πάνω, ενώ φυσιολογικά έχει κλίση ελαφρώς προς τα κάτω (παλαμιαία).

Αρκετά συχνά το κάταγμα της κάτω επίφυσης της κερκίδας μπορεί να συνοδεύεται από κάταγμα της στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης· κάκωση που συνήθως υποδηλώνει συνοδό αστάθεια της κάτω κερκιδωωλένιας άρθρωσης (Distal Radioulnar Joint - DRUJ).

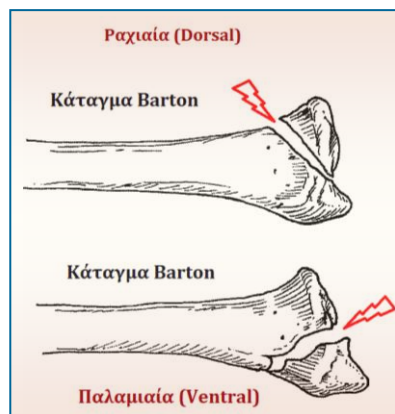
Το κάταγμα τύπου Smith ή ανάστροφο κάταγμα Colles, αφορά σε ένα εξωαρθρικό κάταγμα που συμβαίνει σπάνια, μετά από πτώση πάνω στο χέρι που βρίσκεται σε κάμψη.

Η φυσική εξέταση κι εδώ χαρακτηρίζεται από τον έντονο ως αφόρητο πόνο του άκρου, τάση του ασθενούς για προφύλαξη του άκρου στις κινήσεις, περιτραυματικό οίδημα, ενώ μορφολογικά η πηχεοκαρπική (ΠΧΚ) άρθρωση εμφανίζει παλαμιαία παρεκτόπιση.

Ακτινολογικός, η ακτινογραφική απεικόνιση της ΠΧΚ άρθρωσης με προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία κρίνεται επαρκής για τον ακριβή προσδιορισμό ενός κατάγματος της ΠΧΚ και μπορεί έτσι να διαφοροδιαγνωσθεί ένα κάταγμα Colles από ένα τύπου Smith.

Το κάταγμα Barton, αφορά συνήθως στην παλαμιαία επιφάνεια του κάτω άκρου της κερκίδας (παλαμιαίο Barton) και σπανιότερα στον ραχιαίο φλοιό (ραχιαίο Barton).

Το κυριότερο όμως στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτού του είδους τα κατάγματα, είναι ότι παράλληλα με τη λύση της συνέχειας του οστού συμβαίνει υπεξάρθρωμα ή εξάρθρωμα του καρπού (κερκιδοκαρπικής άρθρωσης). Αυτό σημαίνει ότι το τμήμα της περιφερικής κερκίδας που περιλαμβάνει το κάταγμα, παρεκτοπίζεται παλαμιαία ή ραχιαία μαζί με τον καρπό και το χέρι. Συμβαίνει συνήθως σε νεαρά άτομα και αντιμετωπίζεται πάντοτε χειρουργικά διότι είναι ασταθές.



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Πριν επιχειρήσουμε ανάταξη ή οποιονδήποτε χειρισμό, σκόπιμο είναι να ελέγξουμε τα **ζωτικά σημεία** του ασθενούς και να χορηγήσουμε επαρκή **αναλγησία**, όπως παρακάτω. Η κλινική εξέταση πρέπει να είναι προσεκτική και να γίνεται νευροαγγειακός έλεγχος της λειτουργίας του μέσου νεύρου, αλλά και του ωλένιου που πλήττεται σπανιότερα.
2. Χορηγούμε 1 amp. Voltaren (ή Dynastat ή Vialax) + 1 amp. Musco-Ril (ή Norflex) (im). Χορηγείται επιπροσθέτως, Παρακεταμόλη: 1 amp. Apotel-plus (im) ή 1 fl Apotel 1 g (iv). Εναλλακτικά, 1 fl. *Combogesic* (1 g/300 mg) 100 ml (iv) και 1 amp. *Musco-Ril* (im). Σε ορισμένες περιπτώσεις και επί έντονου πόνου, μπορεί να χρειαστεί η τοπική διήθηση στην περιοχή του κατάγματος με 5-10 ml Ξυλοκαΐνης και ο ψεκάσμος με ψυκτικό spray για επίτευξη τοπικής αναλγησίας και για τη διευκόλυνση των χειρισμών ανάταξης.
3. Σε επιπεπλεγμένο (ανοικτό) κατάγμα της ΠΧΚ άρθρωσης, ενεργούμε ως ακολούθως:
 - ▶ Ανοσοποιούμε τον ασθενή για τέτανο, με HTIG (*inj. Tetagam-P 250 IU*, ενδομυϊκά),
 - ▶ Λαμβάνουμε καλλιέργειες του τραύματος με ειδικό στείλεό (π.χ. τύπου *Stuart*),
 - ▶ Εκτελούμε σχολαστική έκπλυση του τραύματος με άφθονο ισότονο ορό (*N/S, R/L*),
 - ▶ Επιχειρούμε αφαίρεση των ξένων σωμάτων (*θρόμβους, παρασχίδες, θραύσματα*).
4. Επί διακομιδής σε Ορθοπαιδική κλινική, τοποθετείται ειδικός διάφανος αερονάρθηκας (*air splint*) ή ραχιαίος γυψονάρθηκας. Τοποθετούμε, προαιρετικά, φλεβική γραμμή και χορηγούμε 1 amp. Tramadol, εντός 100-250 ml N/S, για αναλγησία, ενώ μεριμνούμε για τη γαστροπροστασία με τη χορήγηση PPI (*Lordin/Nexium*) ή/και Σιμετιδίνης (*Tagamet*).

Η ακινητοποίηση σε γύψο επιτελείται για διάστημα περίπου 4 έως 6 εβδομάδων, ενώ συμβουλευόμαστε τον ασθενή για **τακτική ακτινολογική παρακολούθηση** κάθε 7-10 ημέρες, ιδιαιτέρως κατά τις πρώτες τρεις εβδομάδες, λόγω του κινδύνου απώλειας της ανάταξης, εξαιτίας χαλάρωσης του γύψου από τη σταδιακή υποχώρηση του οιδήματος του καρπού.

Τα μη παρεκτοπισμένα κατάγματα Colles και Smith αντιμετωπίζονται με τοποθέτηση πηχεοκαρπικού γύψινου επιδέσμου για διάστημα τεσσάρων (4) εβδομάδων.

Τα παρεκτοπισμένα κατάγματα τύπου Colles απαιτούν ανατομική ανάταξη και γύψινο επίδεσμο επί πέντε (5) εβδομάδες, ενώ παρεκτοπισμένα κατάγματα τύπου Smith απαιτούν ακινητοποίηση έξι (6) εβδομάδων. Στα παρεκτοπισμένα κατάγματα Colles, η αντιμετώπιση στοχεύει στην κατά το δυνατόν βέλτιστη ανατομική ανάταξη, υπό τοπική αναισθησία, με αποκατάσταση του μήκους της κερκίδας και σωστό προσανατολισμό του περιφερικού τμήματος που περιλαμβάνει την αρθρική επιφάνεια. Ο αντίχειρας και τα δάκτυλα πρέπει να παραμένουν πάντοτε εκτός του γυψονάρθηκα, ώστε να μπορούν να κινούνται ελεύθερα για να αποφευχθούν δυνητικές επιπλοκές, όπως αγκύλωση και ισχαιμία των δακτύλων.

